Autos: 0800312-66.2024.8.12.0009
Classe: Procedimento Comum Cível
Parte autora: Sisleide França Lima Tavares
Parte ré: Município de Costa Rica e Estado de Mato Grosso do Sul

SENTENÇA

Vistos.

Sisleide França Lima Tavares ajuizou *ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela de urgência* em desfavor do Município de Costa Rica/MS e do Estado de Mato Grosso do Sul, todos qualificados, visando compeli-los ao fornecimento dos medicamentos *Pregabalina 75mg.* Alegou que padece de *Tuberculose respiratória (CID 10: A15.6)*, e necessita do fármaco mencionado para amenizar as sequelas da doença, sendo este o tratamento mais indicado, haja vista que outros medicamentos disponíveis no SUS não se mostraram eficazes. Disse que não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, e que o medicamento não está disponível nas listas de dispensação obrigatória pelo SUS, embora seja o indicado para sua patologia. Sustentou que é obrigação dos requeridos o fornecimento do medicamento necessário à recuperação de sua saúde. Requereu, *liminarmente*, em tutela provisória de urgência, a determinação para que os requeridos forneçam o medicamento. Postulou a procedência dos pedidos, a gratuidade da justiça e juntou documentos (f. 14-27).

O feito foi encaminhado para análise do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que emitiu parecer desvaforável ao pedido formulado (f. 28-34).

Em decisão interlocutória (f. 35/38), deferiu-se o pedido de tutela provisória de urgência e concedeu-se a gratuidade da justiça.

Citados, os requeridos apresentaram contestação.

O Estado de Mato Grosso do Sul (f. 53/66), alegou, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. No mérito, disse que a obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado através de atos normativos ao Sistema Único de Saúde deve ser analisada sob o enfoque das teses vinculantes definidas pelo STJ no REsp n. 1.657.156/RJ. Aduziu a ausência de prova acerca da imprescindibilidade do medicamento solicitado e da ineficácia do tratamento com os remédios

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

fornecidos pelo sistema público de saúde. Discorreu sobre a recomendação da Conitec para não incorporação do medicamento pregabalina ao SUS. Argumentou acerca do pedido de restituição de eventuais valores dispendidos pelo requerente. Requereu o acolhimento da preliminar e a improcedência do pedido inicial.

O Município de Costa Rica (f. 88-109) alegou, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. No mérito, alegou que não foram observados os requisitos contemplados no Tema 106 do STJ, especialmente a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Requereu a fixação dos honorários por equidade e justificou a necessidade de repartição proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de procedência do pedido. Requereu a improcedência do pedido inicial e juntou comprovante de cumprimento de obrigação.

As partes foram instadas a indicarem as provas a serem produzidas, tendo sido requerido o julgamento antecipado.

Juntado acordo formulado entre o Estado e o Município em que o último comprometeu-se a cumprir a tutela provisória deferida nos autos (f. 127).

Juntado acórdão do agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, no qual foi negado provimento ao recurso para manter a decisão que deferiu a tutela provisória (f. 139-167).

É o relatório. DECIDO.

1. Julgamento antecipado

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a produção de provas em audiência.

A propósito, em casos da espécie, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que *"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ – 4ª Turma, Resp n.º 2.832-RJ, rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU – 17.07.1990, pág. 9.513)*.

2. Preliminar

A preliminar arguida pelos requeridos referente à inclusão da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

União no polo passivo, com o consequente deslocamento da competência para processar e julgar esta demanda à Justiça Federal não vinga.

Ocorre que a *incorporação* de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde não é objeto desta demanda, mas apenas a *obrigação de fornecimento* destes, que, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é solidária entre todos os entes da federação, o que será abordado com maior profundidade no tópico seguinte desta fundamentação.

É necessário pontuar que a divisão de competências administrativas para o fornecimento de medicamentos (incorporados ou não incorporados), mesmo sob a ótica da Lei n. 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária entre os entes públicos, repercutindo apenas no direcionamento da ordem para o cumprimento da obrigação, conforme tese firmada pelo STF no RE 855.178, em repercussão geral (tema 793): *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"*.

Demais disso, o parecer do NAT (f. 32 – item VIII) esclarece que como o medicamento pleiteado não está padronizado, não é possível indicar o ente público responsável, segundo as normas do SUS, portanto, mesmo considerando a repartição de atribuições administrativas, não se verifica motivo para inclusão da União no polo passivo, afinal, não terá sua esfera jurídica atingida em eventual execução da *obrigação de entregar coisa certa* (não há nada nos autos que indique tal conclusão). Logo, não há falar em incompetência deste juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMS:

> *E M E N T A – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) -*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS GRATUITAMENTE FORNECIDOS PELO PODER PÚBLICO NO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – REQUERENTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO. 1 - A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178- SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. 2 - Não se observa que o entendimento da Suprema Corte altere a ocorrência da solidariedade passiva, nem se traduza em litisconsórcio necessário a redundar na imprescindibilidade da inclusão da União no pólo passivo da demanda. A solidariedade, por sua própria qualidade instrínseca, reflete na existência do litisconsórcio facultativo, pois ocorre "quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda" (art. 264/CC). Neste sentido, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça "segundo o qual, a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário, mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo." (AgRg no Resp 1164933/RJ). 3 - Em que pese a saúde ser direito de todos, consoante respaldo constitucional (arts. 23, II, e 196), a procedência de toda e qualquer ação fundada no tema, conforme vinha ocorrendo sob esse fundamento constitucional genérico e abstrato, terminava por produzir um verdadeiro caos no orçamento público, pois exigia a adoção de providências sem qualquer lastro de previsão financeira, impactando demasiadamente nos cofres públicos e na própria condução das demais políticas públicas, ante a manifesta escassez de recursos. 4 - O art. 196 da Constituição Federal prescreve que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. 5 - Comprovando a paciente a necessidade de um dos medicamentos prescritos - sendo quanto ao outro pleiteado na inicial expressamente relatado pelo médico que o assiste como ineficaz no tratamento-, e não possuindo condições econômicas para suportar o seu custo, deve o Poder Público fornece-lo, porquanto todas as pessoas têm

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

direito à saúde e ao acesso dos meios necessário a sua obtenção. 6 – Sendo o Ente Estadual sucumbente, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais se a autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual, ante a confusão gerada na figura simultânea de credor e devedor do Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com o art. 381 do CC. Orientação perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos de sua Súmula nº 421. 7 - Reexame necessário e recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul parcialmente providos. Recurso da Defensoria Pública Estadual desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar; retificaram parcialmente a sentença, em reexame necessário; deram parcial provimento ao apelo do Estado e negaram provimento ao recurso da Defensoria Pública; nos termos do voto do Relator. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0805150-98.2019.8.12.0018, Paranaíba, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 14/01/2022, p: 17/01/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ADESIVOS PELA AUTORA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SEGUNDO ADESIVO NÃO CONHECIDO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - NÃO ACOLHIDA - SOLIDARIEDADE RECONHECIDA EM TESE FIRMADA PELO STF - TEMA 793 - REQUISITOS DA TESE FIRMADA NO RESP Nº. 1.657.156-RJ - DAFLON - BILASTINA - FOSTAIR - NECESSIDADE COMPROVADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS PLEITEADOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ATUALIZAÇÃO SEMESTRAL DA PRESCRIÇÃO MÉDICA - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE CUNHO CONDENATÓRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO NOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - CONFUSÃO RECONHECIDA - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO SEGUNDO RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. 1. Em razão da preclusão consumativa, não merece ser conhecido o segundo recurso adesivo interposto em face da mesma decisão, pela mesma parte, 2. Não procede o pedido de inclusão da União no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

polo passivo da demanda, haja vista ser solidária a responsabilidade entre os entes federados, no âmbito do direito e garantia à saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer um deles, cabendo à autoridade judiciária promover o direcionamento do cumprimento que "não se trata de formação do polo passivo" da demanda, mas de posterior ressarcimento. 3. O STF, em decisão proferida RE 855.178/SE (Tema 793), de efeito vinculante, reafirmou a sua tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo solidária, portanto, a responsabilidade dos entes federados, o que determina que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 4. Tendo a sentença acolhido o pleito de fornecimento dos medicamentos, dando preferência aos genéricos, carece o ente público estadual de interesse recursal no ponto. 5. Comprovado nos autos, por meio de laudo médico que a paciente padece de insuficiência venosa e trombose venosa profunda – CID 10 I872, I82 e ainda de asma – CID 10 J45.0, não existindo tratamentos oferecidos pelo SUS com a mesma eficácia do indicado, bem como não foi obtido sucesso com o uso de outros fármacos, deve o poder público disponibilizar o tratamento indicado pela médica assistente, ainda quando se trata de pessoa carente de recursos financeiros e há risco de evolução das doenças. 6. Restando evidenciada a necessidade dos medicamentos prescritos e a imprescindibilidade de seu uso, não podendo a paciente arcar com os custos para sua aquisição, impõe-se ao Poder Público o dever de fornecê-lo gratuitamente, independentemente de estar ou não inserido em lista fornecida pelo Ministério da Saúde, dado que o direito à vida é incondicional. 7. Quanto à necessidade de fixação de prazo para apresentação periódica da prescrição médica atualizada, por razoável a sua atualização a cada 6 (seis) meses. 8. A menção de que o gestor público incorrerá em crime de desobediência na hipótese de descumprimento da decisão, é destituída de carga condenatória, não havendo que se falar em sua exclusão. 9. O atraso na entrega dos medicamentos postulados, por si só, não acarreta uma condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais. 10. São indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública oriundos de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, por ocorrer confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. (TJMS. Apelação Cível n. 0801341-79.2020.8.12.0046, Chapadão do Sul, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 21/10/2021, p: 28/10/2021). (Grifei).

3. Mérito

Trata-se de pretensão condenatória em obrigação de entregar coisa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

certa, pela qual a requerente postula o fornecimento de medicamento que não está em lista de dispensação obrigatória pelos entes públicos (não incorporado) para o tratamento de seu problema de saúde, conforme relatado na inicial.

No REsp 1.657.156/RJ, julgado em 21/09/2018, pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 106), cuja decisão é de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), o STJ estabeleceu os critérios para que os entes públicos sejam obrigados a fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, *a saber*:

> *1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> *2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> *3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

No caso dos autos, o laudo da médica que assiste a requerente (f. 19), analisado em conjunto com questionário para pedido judicial de medicamento (f. 23-26), devidamente fundamentado e circunstanciado, além de comprovar a doença indicada na inicial *Tuberculose respiratória (CID 10: A15.6)*, revela a imprescindibilidade do medicamento solicitado para o tratamento da referida moléstia, ressaltando a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS (f. 25).

A incapacidade financeira da requerente em arcar com o custo dos medicamentos prescritos é notória. Como se observa, o valor aproximado do tratamento, é de R$ 116,10 (f. 20), ao passo que a parte autora declarou possuir renda de R$ 650,00 (f. 16), situação apta a indicar que a requerente não possui condições de arcar com os custos do tratamento sem que isso prejudique sua subsistência.

Ademais, o medicamento em análise ostenta registro na ANVISA e seu uso é indicado para inibir dor no sistema nervoso central (f. 30-31).

Outrossim, em que pese o parecer do NAT seja desfavorável à concessão do medicamento (f. 28-34), o laudo médico indica que a requerente já

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

fez uso de várias medicaçãos disponíveis no SUS, sem melhora das sequelas oriundas da doença infecciosa (f. 19).

Nessa ordem de ideias, observo que a requerente preenche todos os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ, de modo que os entes públicos são obrigados a fornecer o medicamento pleiteado na inicial e não incorporado em atos normativos do SUS, qual seja *Pregabalina 75mg.*

Esclarecidos esses pontos, ressalto que o direito à saúde decorre do próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, erigido à categoria de fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF).

A consagração expressa da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal, fruto da nova dogmática desenvolvida a partir do segundo pós-guerra (*pós-positivismo*), faz com que deixe de ser apenas um valor moral para se converter em um valor tipicamente jurídico, passando a ter normatividade, tornando-se o núcleo axiológico do ordenamento jurídico, a partir da compreensão que a pessoa é o centro e o fim do direito.

Não bastasse isso, o art. 5.º, *caput*, da Constituição Federal discorre que: *"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade".* Sendo desdobramento do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se dizer, sem qualquer dúvida, que a saúde é um direito fundamental do cidadão, e, como tal, tem a característica de vincular o Poder Público à sua estrita observância.

O que se está a dizer, sob outro enfoque, é que os direitos fundamentais, por estarem previstos na Constituição Federal, tornam-se parâmetros de organização e de limitação dos poderes constituídos, servindo como verdadeiros *guias* para a atuação do Poder Público, que tem o dever indeclinável de respeita-los e, ainda, por serem elementos da ordem jurídica objetiva, garantir que terceiros também os respeitem.

Além de configurar-se como direito fundamental e, portanto, de observância obrigatória pelo Estado, a própria Constituição Federal disciplina

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado presta-la, consoante se depreende do art. 196: "*A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

A palavra *Estado* empregada no texto constitucional, a toda evidência (e até por questão de hermenêutica constitucional), deve ser interpretada em seu sentido *lato*, de modo a entender que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar assistência integral à saúde dos cidadãos (trata-se de um direito fundamental prestacional – 2ª dimensão).

Em outras palavras, pela norma constitucional, há um dever solidário de assistência à saúde, o que significa dizer que todos os entes políticos, seja qual for a esfera – Federal, Estadual, Distrital ou Municipal –, têm responsabilidade solidária no atendimento à saúde da população.

A legislação infraconstitucional também impõe esse dever ao Estado (em sentido *lato*), ao dispor, no art. 2º da Lei n. 8.080/90, posteriormente alterada pela Lei n. 12.401/2011, que regulamenta as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, que *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".*

Portanto, à luz do sistema constitucional e legal, o cidadão pode pleitear a concessão de medicamentos perante qualquer esfera governamental, pois o dever abarca todos os entes, que atuam na promoção da saúde num sistema de consórcio, mais precisamente, o Sistema Único de Saúde, e este é exatamente o caso tratado nos autos, a parte requerente postula o fornecimento de medicamento em face do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Costa Rica/MS.

Nessa linha de entendimento é a jurisprudência do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

PACIENTE PORTADOR DE ASTROCITOMA ANAPLÁSICA DO ENCÉFALO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE 800051 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 834566 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014) (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O tratamento médico bem como o fornecimento de medicamentos a pacientes hipossuficientes são deveres solidários dos entes federados de qualquer esfera (federal, estadual e municipal). Precedentes: ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014, RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013 e RE 820.910-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 4/9/2014.2. [...]. (STF - RE: 835299 TO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/10/2014, Data de Publicação: DJe-207 DIVULG 20/10/2014 PUBLIC 21/10/2014). (Grifei).

No mesmo rumo é a jurisprudência do TJMS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CF/88 – PACIENTE PORTADORA DE GLAUCOMA - DIREITO À SAÚDE (ARTIGO 196, CF/88) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO-POSSIBILIDADE – URGÊNCIA E VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS - RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA 106) - REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA - MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal. A previsão do medicamento pleiteado nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado, não afasta a solidariedade estatal, como igualmente assentado pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.657.156/RJ) decidiu que para concessão de medicamentos que não integram o SUS é necessário a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No que tange ao arbitramento de multa diária para o caso de descumprimento verifico que diante do objetivo da medida esta se demonstra razoável para o adimplemento da decisão. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 2001103-37.2019.8.12.0000, Corumbá, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 09/06/2020, p: 15/06/2020)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PESSOA IDOSA PORTADORA DE GONARTROSE DE JOELHO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À SAÚDE E RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO – PARECER DO NAT FAVORÁVEL - RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I - Todos os Entes Federados (União, Estados e Municípios) são partes legítimas para responderem demandas em que visam à condenação em obrigação de fazer, substanciada no fornecimento de medicamento ou outras prestações de saúde (consulta médica, por exemplo). Assim, ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde, não se há falar em ausência de legitimidade passiva do Município. II - A saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deverá garantir à sociedade a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. (TJMS. Apelação Cível n. 0800522-06.2019.8.12.0038, Nioaque, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 31/05/2020, p: 08/06/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRATAMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À SAÚDE - URGÊNCIA E NECESSIDADE CARACTERIZADAS – OBRIGAÇÃO MANTIDA - ATENDIMENTO DA AUTORA NA VIA PARTICULAR, HONORÁRIOS MÉDICOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS – PEDIDOS NÃO CONHECIDOS - MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADMISSÍVEL – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS CONFORME SENTENÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. Todos os entes federativos são integralmente responsáveis pela saúde da população, não cabendo a qualquer deles imputar ao outro o dever de promover ações tendentes ao resguardo da saúde do cidadão necessitado. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado afastada. Restaram comprovadas nos autos a enfermidade da autora, sua hipossuficiência econômica e a necessidade de submeter-se ao procedimento cirúrgico pleiteado, em caráter de urgência, sob pena de agravamento de seu quadro clínico, devendo ser rechaçada a tese do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

réu no sentido de tratar-se de cirurgia eletiva. Lado outro, em relação às questões sobre possível atendimento da autora via particular, pagamento de honorários médicos, utilização de materiais não padronizados pelo SUS, não conheço tais pedidos, porquanto sequer pleiteados pela autora tampouco abordadas pelo juízo de origem. No tocante ao cabimento de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, tenho que é plenamente cabível como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou, de sentença definitiva de obrigação de fazer ou, de entregar coisa, nos termos dos artigos 497 e 498, ambos do CPC, estando adequado e proporcional o valor arbitrado pelo juízo. Quanto ao ônus de sucumbência, em sede de reexame obrigatório, não vejo necessidade de alteração, devendo ser confirmada a sentença neste ponto. (TJMS. Apelação Cível n. 0801271-98.2019.8.12.0013, Jardim, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 26/05/2020, p: 28/05/2020)

Por todos os ângulos que se observa a questão em análise, afigura-se visível que a parte autora está acometida de tuberculose respiratória, necessita do medicamento pleiteado, e não tem condições financeiras para suportar as despesas do tratamento sem prejuízo da própria subsistência, portanto, tem o direito de receber do Estado (sentido *lato*) – que por sua vez tem o dever de disponibilizar –, a assistência adequada para a recuperação de sua saúde.

ISSO POSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, *mantendo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência de f.* 35-38, condenar o Município de Costa Rica/MS e o Estado de Mato Grosso do Sul, *solidariamente*, a fornecer à requerente Sisleide França Lima Tavares, qualificada, o medicamentos *Pregabalina 75mg*, necessário ao tratamento da patologia, enquanto perdurar a necessidade, conforme prescrição médica de f. 19. f. 23-26 e f. 27.

Outrossim, em atenção à tese definida pelo STF no RE 855.178, julgado em 23/05/2019, em repercussão geral (tema 793)[1], mas diante da inexistência de indicação de qual ente público é o responsável pelo fornecimento

[1] *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

do medicamento (*vide* parecer do NAT às f. 28-34, item VIII), deixo de direcionar o cumprimento da obrigação a um dos requeridos, de modo que ambos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento do referido medicamento.

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante a isenção conferida à Fazenda Pública (art. 24, I, da Lei Estadual n. 3.779/09).

Nos termos dos arts. 87 e 90 do CPC, e à luz do princípio da causalidade, condeno os requeridos[2] Município de Costa Rica/MS e Estado de Mato Grosso do Sul[3], *solidariamente*, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (FUNADEP), os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)[4], na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o grau de zelo empregado da causa.

A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário, tendo em vista a regra estabelecida no art. 496, § 4º, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquive-se.

Costa Rica, data da assinatura digital.

---

[2]*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS - ART. 87 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 87 do CPC, restando vencidos ambos os entes requeridos, deve haver a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, ainda que um desses esteja desobrigado do pagamento. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJMS. Apelação Cível n. 0801049-11.2020.8.12.0009, Costa Rica, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/09/2021, p: 06/10/2021)*

[3] STF, RE 1.140.005, repercussão geral, tema 1.002.
Tese: *"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".*

[4] É assente na jurisprudência o entendimento de que nas ações movidas contra a Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, considerando que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC (STJ, AgInt no REsp 1.976.775; TJMS, AC 0800457-94.2017.8.12.0033 – Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.

Laísa de Oliveira Ferneda Marcolini

Juíza de Direito

(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAISA DE OLIVEIRA FERNEDA MARCOLINI, liberado nos autos em 25/03/2025 às 18:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800312-66.2024.8.12.0009 e código wl5pVueQ.